

Psychotropes et tremblements

👉 Les tremblements sont un effet indésirable fréquent des traitements psychotropes. Ils sont le plus souvent sans gravité, mais peuvent être gênants pour accomplir les tâches quotidiennes, et source de stigmatisation dans les relations sociales en rendant « visible » la prise de médicaments.

👉 Les psychotropes peuvent entraîner l'apparition de tremblements

- ▶ de repos (muscles décontractés)
- ▶ d'action (muscles contractés) qui peuvent être posturaux (maintien d'une posture contre la gravité, par ex tenir un verre) ou intentionnels (atteindre une cible, par ex diriger une tasse vers sa bouche, signer un chèque).

👉 Avant d'attribuer un tremblement à un médicament, il faut s'assurer qu'il n'est pas lié à une autre cause : maladie de Parkinson (⚠️ si le tremblement n'est pas symétrique), hyperthyroïdie, hypoglycémie par ex.

👉 Plusieurs psychotropes induisent des tremblements :

- 💊 lithium : le plus souvent, tremblement postural et d'intention, plus rarement, tremblement de repos (syndrome parkinsonien). ! ⚠️ si le tremblement apparaît brusquement ou devient très intense avec des mouvements incontrôlés, c'est un signe de surdosage !
- 💊 valproate : tous les types de tremblements, qui peuvent parfois concerner la tête et les membres inférieurs
- 💊 antidépresseurs : le plus souvent, tremblement postural et de repos
- 💊 antipsychotiques : le plus souvent, tremblement de repos lié à un syndrome parkinsonien ; ! ⚠️ avec la clozapine, des mouvements brusques (myoclonies) ne sont pas des tremblements, c'est un signe de surdosage ou de risque convulsif.

👉 Tous les tremblements sont aggravés par

- ▶ l'anxiété (incluant l'anxiété sociale déclenchée par le regard d'autrui)
- ▶ la caféine, le tabac, les psychostimulants (cocaïne)
- ▶ le sevrage en alcool ou en benzodiazépines

👉 Les tremblements liés aux psychotropes sont dose-dépendants, et peuvent être améliorés :

- ▶ en réduisant (si possible) la dose
- ▶ en prenant la dose la plus forte le soir (pic nocturne)
- ▶ avec la forme à libération prolongée si elle existe (valproate et lithium)(pour diminuer les pics)
- ▶ pour les antipsychotiques, en changeant pour une molécule induisant pas ou peu de syndrome parkinsonien (par ex olanzapine, aripiprazole, quétiapine; la clozapine peut être indiquée même en l'absence de résistance)
- ▶ en limitant les co-prescriptions

👉 Si ces stratégies ne sont pas suffisantes, un traitement médicamenteux peut être envisagé :

- 💊 tremblement d'action (lithium, valproate, antidépresseurs) : bêta-bloquants par ex propranolol 30-60 mg
- 💊 tremblement de repos (antipsychotiques) : « correcteur » anticholinergique ; ! ⚠️ inutile pour les myoclonies de la clozapine (surdosage ou risque convulsif).

Références 📄

<https://lnkd.in/euXv999u>

<https://lnkd.in/efp-5xhj>

Psychotropes et tremblements

